EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 94740
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-10-13 13:48:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: CESAR RENE BASCUR BASCUR			RUN	: 13.617.964-0
F.Nac	: 06-05-1971	Edad	: 53 AÑOS, 5 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: POB. 11 SEPT. ARRAYAN 0637			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA D	Teléfono	: null		
Fecha Ingreso	: 2024-10-12	Fecha Egreso	: 2024-10-13 13:48:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

PNAg en vias de resolucion

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente sin antec morbidos, consulta en SU el 11/10 por cuadro de 2 dias de evolucion de sensacion febril, algia abdominal tipo colico. Se realizan examenes de lab compatibles con ITU, se procede a inicio de terapia ATB de primera linea con ciprofloxacino. Se rescata URC que describe desarrollo de E. Coli multirressitente, sensible a amikacina, nitrofurantoina, gentamicina, meropenem, imipenem, trimetotrpm sulfametoxazol, piperalicina-tazobactam, ertepanem

Examenes de lab al ingreso -> crea 0,8; lactato 1,3; PCR 249; uremia 39; Na/K/Cl 139/4/102; Hb/Hcto 11,8/35,5; GB 14,2; plaq 386000; segment 77%.

Se decide ingreso para inicio de terapia ATB

Durante su estadia HDN estable, sin nuevas molestias, se solicitan examenes de lab control 13/10 -> crea 0,6; lactato 2; PCR 183,2 (prev 249), Hb/HCto 11,7/35, Gb 6; plaq 370000; segment 72%, proca 0,34
Se decide hospitalizacion para inicio de terapia ATB con carbapenemicos y monitorizacion
Durate su estadia HDN estale, afebril, con menores molestias en comparativa a ingreso, se rota ATB a amikacina

Ex fisico -> Vigil; CLOTE, mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Abdomen BDI, RHA (+), sin megalias, sin signos de irritacion peritoneal

Con descenso de parametros inflamtorios, en vista de condciones clinicas,a ctualmente cursanso su dia N° 1 hospitalizado, dia N° 1 de amikacina, en condiciones de continuar hospitalizacion via HODOm

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: estable, sin conflicto
3) Infeccioso: Se procede a ajuste de terapia ATB con amikacina, se completaran 7 dias en total, con control con parametros inflamatorios en 48 hrs
4) Renal: Seguimiento de esfera renal detro de 48 hrs por riesgo de nefrotoxicidad 2° a uso de amikacina

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Regimen liviano a tolerancia
3. Amikacina 1 gr al dia EV por 6 dias mas (completar 7 dias en total)
4. Omeprazol 20 mg al dia VO por 6 dias
5. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/8hrs VO por 6 dias
6. Metamizol 300 mg c/!2 hrs VO por 6 dias

7. Metoclopramida 10 mg c/!2 hrs VO SOS por 6 dias
8. Dolospam un comp c/12 hrs VO SOS por 6 dias
9. Examenes de control 15/10

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO